L'épuisement professionnel (Burn out)

Dr A.BELKASSA

Maitre assistante EN MEDECINE DU TRAVAIL

Faculté de médecine , Alger

Année universitaire 2026-2027

Plan

- Introduction
- Définitions
- Les facteurs de risque
- Les professions à risque
- Les manifestations cliniques
- Diagnostic
- Prevention
- Conclusion

Introduction

- Toute activité professionnelle comporte des tâches, des responsabilités, des problèmes.
- Les exigences et les contraintes font inévitablement partie de la vie au travail.
- La satisfaction d'un travail bien accompli récompense souvent l'effort déployé à la fois pour effectuer la tâche et pour faire face aux contraintes et pressions de l'environnement du travail.

Introduction

- Dans la plupart des cas, il existe un équilibre entre les exigences et les contraintes d'une part et la compétence, la capacité physique et mentale du travailleur d'autre part ; la charge de travail est alors considérée comme raisonnable.

- En revanche, lorsque la personne est incapable de faire face aux sollicitations soit parce que les contraintes sont excessives soit parce qu'une usure chronique diminue les ressources disponibles, l'équilibre est rompu.

Introduction

- Le déséquilibre profond et durable entre demandes et capacités caractérise l'état de stress lequel, en retour, a des conséquences sur le travail et les relations au travail.

Introduction

- Origine et développement du concept:

Le terme "burn out" qui exprime l'idée d'un épuisement ou d'une usure professionnelle, décrivant un ensemble de symptômes psychologiques et relationnels, a fait son apparition dans la recherche en psychologie au milieu des années 70.

Introduction

- Freudenberger (1974) " Première description du burn out" : Herbert Freudenberger, psychanalyste américain est considéré comme le père spirituel du burn out. Son article publié en 1974 en est la première tentative de description. Il utilise le premier cette expression originale pour désigner **un état particulier de détresse** observé chez de jeunes bénévoles enthousiastes, disponibles et idéalistes, qui intervenaient dans une clinique de jour New-yorkaise, accueillant des toxicomanes.

Introduction

- En 1980, Freudenberger donne la définition suivante du burn out : " Un état de fatigue chronique, de dépression et de frustration apporté par la dévotion à une cause, un mode de vie, ou une relation, qui échoue à produire les récompenses attendues et conduit en fin de compte à diminuer l'implication et l'accomplissement au travail".

Définitions-Cadre conceptuel du syndrome d'épuisement professionnel « burn out ».

- ***« Je me suis rendu compte au cours de mon exercice quotidien que les gens sont parfois victimes d'incendies tout comme les immeubles. Sous l'effet de la tension produite par la vie de notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur , même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. »***

Herbert Freudenberger.



Définitions-Cadre conceptuel du syndrome d'épuisement professionnel « burn out ».

- Le dénominateur commun de l'ensemble des définitions de l'épuisement professionnel est un état de fatigue et d'usure ressenti comme étant en lien avec le travail.

Définitions-Cadre conceptuel du syndrome d'épuisement professionnel « burn out ».

- **Les définitions en termes d'état**

Après plusieurs années d 'investigations auprès de populations de travailleurs sociaux Maslach et Jackson (1981), vont définir le burn out comme un modèle tridimensionnel et séquentiel qui apparaît chez les individus impliqués professionnellement auprès d'autrui et qui associe

un syndrome d'épuisement émotionnel

dépersonnalisation (cynisme ou déshumanisation)

r é d u c t i o n de l'accomplissement personnel

Définitions-Cadre conceptuel du syndrome d'épuisement professionnel « burn out ».

Trois dimensions:

l'épuisement émotionnel : se traduit par une fatigue affective au travail, une difficulté à être en relation avec les émotions de l'autre , sentiment d'être « vidé ». C'est la composante clé du syndrome ;

« A la fin d'une journée je me sens émotionnellement vidé »

la " déshumanisation ou "cynisme" : se traduit par un détachement excessif dans les rapports interpersonnels pouvant aller jusqu'au cynisme, une plus grande routine du travail avec une tendance à traiter les autres comme des objets ;

« je crains que ce travail me rende insensible »

le manque d'accomplissement personnel : plus le sujet fait d'efforts pour faire face, plus il s'épuise, plus il perd son efficacité, plus il se démotive, installant par là même une sorte de cercle vicieux où il finit par douter de ses propres capacités, baisse les bras et éprouve un réel manque d'accomplissement

« Je ne me sens pas très efficace ».

Définitions-Cadre conceptuel du syndrome d'épuisement professionnel « burn out ».

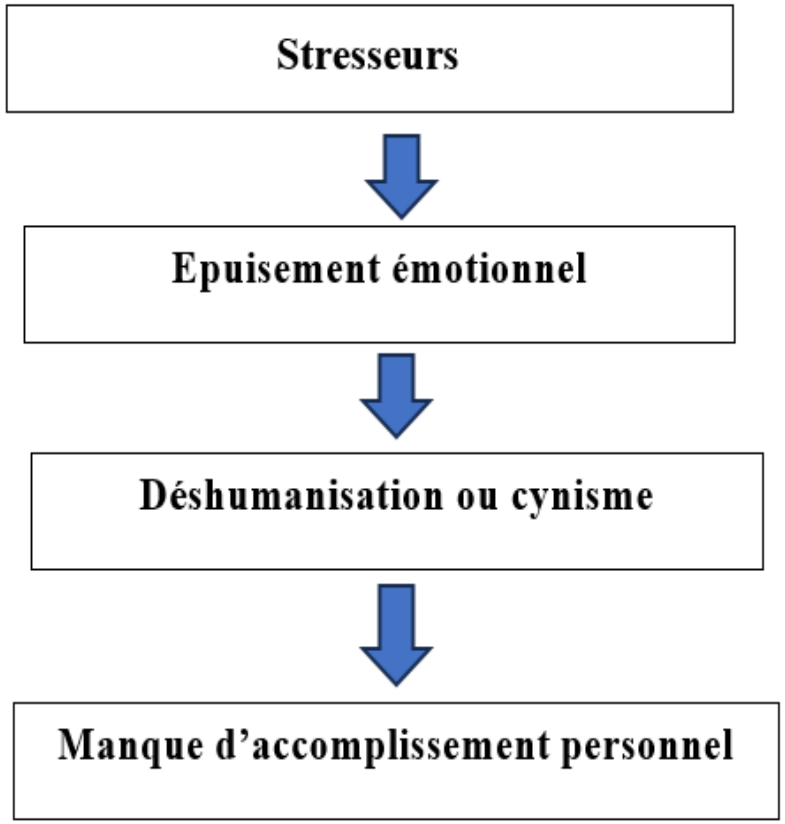


Fig. 1 : Le processus de burn out d'après le modèle tridimensionnel de Maslach et Jackson

Définitions-Cadre conceptuel du syndrome d'épuisement professionnel « burn out ».

- **Les définitions en termes de processus**

À partir des années 1980, le syndrome d'épuisement professionnel est décrit et étudié dans d'autres métiers que ceux impliqués dans la relation d'aide à autrui et s'est étendu à toutes les catégories professionnelles

Les professions à risque

- L’exposition au risque de burnout peut concerner les professions d’aide, de soins, de l’enseignement… des professions où la relation à l’autre est au centre de l’activité et constitue un enjeu, parfois vital, pour les bénéficiaires de cette relation (les usagers, les patients, les clients, …).

- Toutefois le burnout peut également concerner d’autres secteurs d’activité susceptibles de mobiliser et d’engager les personnes sur des valeurs professionnelles très prégnantes.

Les facteurs de risque

- La survenue du burn out résulte de la réunion d'un ensemble de **facteurs individuels** et des **facteurs de risques psycho-sociaux (RPS)** liés aux des situations de stress et des agents stressants.

Les facteurs de risque

1. Facteurs de risque individuels

- Dans la majorité des travaux : pas de prise en compte des modérateurs potentiels:
  - ✓ les antécédents personnels et familiaux,
  - ✓ les événements de vie,
  - ✓ la qualité du support social
  - ✓ le rapport au travail.

Les facteurs de risque

1. Facteurs de risque individuels

- Ces facteurs individuels ne peuvent servir qu'à préconiser une prévention renforcée, et ne sauraient bien sûr en aucun cas constituer un élément de sélection des travailleurs, ni exonérer la responsabilité des facteurs de risque présents dans l'environnement de travail.
- La notion de surengagement est tout de même souvent présente…

Les facteurs de risque

1. Facteurs de risque individuels

- Le surengagement

• **facteur clef** de l'épuisement professionnel

• a lui-même des causes : faire de son travail le centre de sa vie, avoir des attentes élevées envers soi-même, faire preuve d'un idéalisme extrême sans se laisser la possibilité de transiger, négliger d'évacuer les tensions en ayant des activités non professionnelles, difficulté à déléguer, volonté d'être apprécié de tout le monde, faible estime de soi, confusion entre performance professionnelle et valeur personnelle, etc.

Les facteurs de risque

1. Facteurs de risque individuels

- Le surengagement

• !!!! burn out ≠ faiblesse personnelle préexistante:

– c'est bien l'environnement dans lequel les individus travaillent, notamment l'organisation du travail, qui génère le burn out et non les personnes elles-mêmes

– ou, plus exactement, leur incapacité supposée à assumer les exigences de leur emploi.

• Le burn out survient chez des sujets n'ayant connu antérieurement aucun trouble mental.

Les facteurs de risque

2. Les facteurs à l'origine des risques psychosociaux sont nombreux, un collège d'experts internationaux, a proposé de les regrouper en six catégories (rapport Gollac):

a) **intensité et organisation du travail** (surcharge de travail, imprécision des missions, objectifs irréalistes, etc.) ;

b) **exigences émotionnelles importantes** avec confrontation à la souffrance, à la mort, devoir cacher ses émotions, peur ;

c) **autonomie et marge de manœuvre** ; faible possibilité pour le travailleur de s'auto-organiser dans son travail, de participer aux décisions.

Les facteurs de risque

2. Les facteurs à l'origine des risques psychosociaux sont nombreux, un collège d'experts internationaux, a proposé de les regrouper en six catégories (rapport Gollac):

d) relations dans le travail (conflits interpersonnels, manque de soutien du collectif de travail, management délétère, etc.) ;

e) conflits de valeurs ;

f) insécurité de l'emploi.

Les facteurs de risque

- **Analyse des conditions de travail** :

démarche structurée, coordonnée par le médecin du travail avec l'appui de l'équipe pluridisciplinaire (ergonome, psychologue du travail, etc.)

Manifestations cliniques

- Ensemble syndromique
- Manifestations + ou - importantes, installation progressive et souvent insidieuse, en rupture avec l'état antérieur, notamment (liste non exhaustive) :

a) **émotionnelles** : anxiété, tensions musculaires diffuses, tristesse de l'humeur ou manque d'entrain, irritabilité, hypersensibilité, absence d'émotion ;

b) **cognitives** : troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, des fonctions exécutives ;

c) **comportementales ou interpersonnelles** : repli sur soi, isolement social, comportement agressif, parfois violent, diminution de l'empathie, ressentiment et hostilité à l'égard des collaborateurs ; comportements addictifs ;

Manifestations cliniques

- Ensemble syndromique
- Manifestations + ou - importantes, installation progressive et souvent insidieuse, en rupture avec l'état antérieur, notamment (liste non exhaustive) :

d) **motivationnelles ou liées à l'attitude** : désengagement progressif, baisse de motivation et du moral, effritement des valeurs associées au travail ; doutes sur ses propres compétences (remise en cause professionnelle, dévalorisation) ;

e) **physiques non spécifiques** : asthénie, troubles du sommeil, troubles musculo-squelettiques (type lombalgies, cervicalgies, etc.), crampes, céphalées, vertiges, anorexie, troubles gastro-intestinaux.

Manifestations cliniques

• Ces symptômes ne touchent pas uniquement des catégories déterminées de professions mais concernent l'ensemble du monde du travail : travailleurs salariés autant que travailleurs indépendants, travailleurs du secteur privé autant qu'agents du secteur public – avec une prévalence plus importante chez les travailleurs exposés au public

Manifestations cliniques

- L’approche par les étapes

L’apparition du syndrome s’organiserait autour de quatre étapes :

1) **l’enthousiasme** : l’individu a un haut niveau d’énergie, il est ambitieux, il a des idéaux et des objectifs élevés. Il se consacre à son travail avec énergie même si celui-ci est très exigeant et si les conditions ne sont pas favorables. Il « réussit » ou, en tout cas, retire une certaine satisfaction de son travail

Manifestations cliniques

- L’approche par les étapes

L’apparition du syndrome s’organiserait autour de quatre étapes :

2) **le surinvestissement** : dans cette deuxième phase, l’individu plafonne : il se rend compte que, malgré ses efforts constants, sa carrière n’évolue pas comme il voudrait, que sa satisfaction ne grandit pas ou que ses efforts ne sont pas reconnus. On exige toujours plus de lui, ou lui-même se fixe des objectifs toujours plus élevés. Il redouble d’ardeur, se met à travailler le soir et le week-end et, surtout, ne déconnecte jamais psychologiquement ;

Manifestations cliniques

- L’approche par les étapes

L’apparition du syndrome s’organiserait autour de quatre étapes :

3) **la désillusion** : fatigué et déçu, l’individu commence à perdre tout espoir. Ses efforts sont méconnus ou ne sont pas appréciés à la hauteur de ce qu’ils représentent. Les premiers signes cliniques apparaissent : impatience, irritabilité, cynisme, isolement, troubles somatiques ;

Manifestations cliniques

- L’approche par les étapes

L’apparition du syndrome s’organiserait autour de quatre étapes :

4) **le burn out** : la dernière phase correspond au burn out proprement dit.: l’individu perd tout intérêt pour son travail et pour son entourage professionnel, voire personnel. Il a brûlé toutes ses réserves et se sent totalement épuisé et découragé. Il n’est tout simplement plus capable de travailler

Diagnostic

- La distinction du Burn out de la dépression est essentielle. Contrairement aux individus qui souffrent de dépression, les victimes du syndrome d'épuisement professionnel manifesteront de la colère et attribueront leur état à leur travail.

- Une absence d'idéation suicidaire et peu d'apathie sont notés.
- S'il existe des sentiments dépressifs, ils restent le plus souvent localisés au secteur professionnel et n'envahissent pas les autres domaines de la vie.
- Il n'y a pas habituellement de ralentissement psychique et /ou moteur.

Prévention

- Pour prévenir l'apparition du phénomène d'épuisement professionnel, il est recommandé de veiller à ce que l'organisation du travail et les contraintes qu'elle génère ne surchargent pas les salariés et ne les mettent pas en porte-à-faux vis-à-vis des règles et des valeurs de leur métier.

- Il convient également de permettre le travail en équipe ou encore de favoriser le soutien social. Et de manière plus générale, il est recommandé de mettre en place une démarche de prévention collective des Risques psychosociaux (RPS).

Prévention

- **Repérer les situations de burnout**
- Au niveau individuel, l'employeur, l'encadrement, les acteurs de la prévention au sein de l'entreprise, le service de santé au travail doivent être vigilants à un ensemble de signaux pouvant laisser penser qu'un salarié est peut-être en situation de burnout :

- Le salarié se plaint-il de manquer d'énergie pour accomplir son travail ?
- Fait-il part de problèmes de concentration, de manque de disponibilité mentale au travail ?
- Est-il facilement irritable ?
- Dévalorise-t-il le travail qu'il accomplit, sa propre efficacité et ses compétences ?
- Manifeste-t-il des signes de désinvestissement professionnel,

Prévention

- **Repérer les situations de burnout**

- Un changement dans l'attitude du salarié, un repli sur soi, un désengagement inhabituel sont autant de signaux qui doivent interpeller l'entourage professionnel.

- Au niveau collectif, les indicateurs de dépistage des risques psychosociaux pourront être examinés.
  Le repérage du burnout peut également se faire par questionnaires.

Prévention

- **Mettre en place des mesures de prévention collective**
- Des mesures de prévention adaptées doivent être recherchées et mises en place. Elles ont pour objectif de faire diminuer les exigences professionnelles qui pèsent sur les salariés et d’augmenter les ressources à leur disposition.

Prévention

- **Mettre en place des mesures de prévention collective**

✓ Exemples de mesures de prévention :

- Veiller à ne pas surcharger certains postes ou certains salariés,
- Favoriser le soutien social et éviter l'isolement : mise en place de groupes d'échanges sur les pratiques professionnelles, renforcement du travail en équipe (temps de travail réservé aux relèves de postes, espaces de partage d'expérience et d'échanges),
- Améliorer le retour sur l'efficacité du travail, la reconnaissance du travail accompli,
- Être vigilant au traitement équitable des salariés,
- Eviter les conflits éthiques autour de la qualité du travail, en partageant les objectifs et les manières de faire pour les atteindre.

Prévention

- **Prendre en charge les personnes atteintes du burnout**

- ✓ Quand une ou plusieurs personnes sont victimes d'épuisement, l'encadrement peut leur proposer un entretien permettant de faire le point sur leurs difficultés. Les raisons de leur état en lien avec le travail doivent être recherchées.
- ✓ Elles peuvent parallèlement contacter le médecin du travail. Celui-ci estimera la nécessité d'une orientation vers une prise en charge spécialisée et appréciera l'opportunité d'un aménagement de poste ou d'une redéfinition des objectifs et des moyens à leur disposition.
- ✓ Le service de médecine du travail peut également aider l'entreprise à repérer les facteurs de risques professionnels en lien avec les cas de burnout portés à sa connaissance.

Conclusion

- Le syndrome d’épuisement professionnel est un syndrome résultant d'un stress chronique au travail suite à un déséquilibre entre les ressources mobilisables par le sujet et les contraintes imposées par le contexte de travail.

Conclusion

- Il est caractérisé par trois dimensions ; un épuisement émotionnel, une distanciation accrue par rapport au travail, ou sentiments de cynisme liés au travail, un accomplissement professionnel réduit.

- Il est causé par le travail et frappe des individus "normaux".

Conclusion

- Il n’est par conséquent, pas considéré, à ce jour, comme une catégorie diagnostique individualisée. Il reste un diagnostic d’élimination à l’échelle individuelle, afin d’exclure tout trouble psychopathologique sous-jacent

- Il est important de se rappeler que les principaux facteurs à l’origine de l’épuisement professionnel sont en lien avec l’organisation du travail

- La démarche diagnostique implique de les rechercher afin de les prendre en compte dans un objectif de prévention, et ce, en étroite collaboration avec le médecin du travail.